

CHANGE Statement

** Français est ci-dessous **

CHANGE (Community Health and HIV Advocates Navigating Global Emergencies) is a coalition of over 1,500 people from civil society and community-led organisations around the world. The coalition was created in January 2025 to respond to the health financing emergency triggered by the withdrawal of the United States government from foreign assistance. This statement was developed in partnership with HIV, tuberculosis, and malaria advocates, organizations, and civil society networks worldwide.

Responding to the funding crisis

The CHANGE coalition acknowledges the **extraordinarily high financial risks facing the Global Fund** in this cycle and looking ahead to Grant Cycle 8. A rapid and chaotic withdrawal and reductions of United States bilateral aid and proposed cuts to partner organizations, including WHO, UNAIDS, and Gavi, have created a global health crisis. This chaotic withdrawal has enabled and normalized other donor countries to propose their own reductions in development assistance, compounding the financial crisis. A recent analysis indicates that a complete withdrawal of US support for HIV, tuberculosis, and other programs will result in 25 million deaths over the next 15 years¹.

The decision to immediately “slow down” Grant Cycle 7 (GC7) grant implementation, as well as additional decisions to be taken at the Board meeting regarding how to deallocate GC7 funds, carry **extremely high risks to the lives of the people** whom the Global Fund serves. The CHANGE coalition is alarmed that communication so far from the Secretariat has lacked specificity, failed to safeguard entire pillars of the Global Fund strategy, declined to mandate country oversight, and was implemented without engagement of the Board and partnership.

We call for the Secretariat to **urgently release clear guidance to countries, including community and civil society partners**, about slow-downs to implementation, timelines, the pathway for reprogramming Global Fund grants (including processes to ensure community engagement in decision-making) to respond to immediate gaps left by the US government’s funding withdrawal, and clear guardrails to safeguard life-saving programs.

Global Fund must:

1. **Communicate that community interventions are lifesaving, and that slowing down GC7 implementation is not a license to decimate community-led interventions.**
2. **Require approval of the full CCM and community input.** Given the significant disruption happening in countries, the high risk of core programmes being deprioritised, and emerging reports of escalating stigma, discrimination, and barriers to care for key

¹ Stover J, Sonneveldt E, Tam Y, Clark R, Phillips AN, et al. [The Effects of Reductions in United States Foreign Assistance on Global Health](#). Lancet (pre-print). 8 Apr 2025.

and vulnerable populations, all ‘slow down’, cuts, and reprogramming must be accompanied by documentation of how **the entire CCM was engaged in and provided written approval all the decisions** to pause implementation or reprogram activities. Reprioritization efforts without community input risk being ineffective and unstrategic, as communities bring data and intelligence that traditional systems lack. These same principles must apply to C19RM funding and catalytic investments.

3. **Define a reprioritization methodology for GC7 that adheres to Global Fund principles.** Rapidly scaling down grants should not undermine the Allocation Methodology’s responsiveness to country need, equity, and capacity. Preferentially defunding countries for their pace of absorption or their implementation timelines is unacceptable.
4. **Immediately share guidance regarding this implementation pause** with all CCMs, as well as civil society, key population, and community networks. This outreach must include explicit efforts to ensure that community CCM representatives and their delegations are fully informed about, understand, and are part of the decision making on the slow-down, reprioritization, and reprogramming process. The involvement of the Regional Learning Hubs and global key population networks will be vital to ensure that CCM members and their constituencies are reached and fully supported.
5. **Decouple immediate financial challenges from GC8 planning.** The need to avoid a financial crisis due to unconverted pledges should be approached with a different strategy than planning for a weak Eight Replenishment. We strongly urge the Board to pause implementation to the minimum extent necessary to avoid cash flow challenges. In parallel, the Secretariat must propose a longer-term scale-down, transition, and prioritization methodology that holistically addresses the gaps left by the U.S. government, reprograms toward urgent needs, and includes transparent and realistic pathways for transitioning and scaling down. This should come to the next Committee meetings.
6. **Ensure that ‘slowing down’ and reprioritization** occurs with clear Board oversight in the event that full TRP review is not possible (e.g., establish an ‘Expedited-TRP’ process to streamline and expedite review), to ensure alignment with the Global Fund core operating principles, governance structures and the country context. In the process of ‘slowing down’ or reprioritizing country-developed, TRP-reviewed, and Secretariat-approved activities, the Global Fund’s principles of **governance, oversight, and programming focus cannot be discarded in favor of financial expediency.**
7. **Be accompanied by regular, granular, and public releases of data.** Rapid changes to grant budgets creates an alarming risk to transparency. The Secretariat must commit to full public reporting on what interventions, at what cost, have been affected across



country-level and disease portfolios as a result of reprioritization efforts. Additionally, despite being more than 16 months into GC7 implementation, no absorption data have been released for the entire cycle. As countries begin pausing programs and directing grant budgets toward emergent gaps, these data must be released to allow reprioritizing that minimizes disruption of existing programmes.

8. **Be accompanied by a portfolio-level analysis by the Secretariat** to leverage unspent allocation budget via Portfolio Optimization and other pathways, to support the redistribution of country medicine stocks to address supply chain challenges, and to increase pooled procurements and negotiate further savings. This must include scenario planning. We urgently call upon the Secretariat to release mandatory **guidance to Country Teams to enforce guardrails** around the defunding of community-focused programs.

Resource Mobilization Update

With the greatest urgency, we strongly call on donors to honor the commitments made in the 7th Replenishment.

Noting the very high risk of a low Replenishment scenario, we urge the Global Fund to take an ambitious approach to resource mobilization. This should include developing proposals for new funding mechanisms for donors, including the private sector, but also the public sector donors. We urge the Secretariat to consider the following approaches:

A call for creative pathways for donor pledges that secure resources for the Global Fund while protecting its core Strategy. As a multilateral institution supporting country-led, evidence-informed programming, imposing donor conditionalities on Global Fund resources creates a significant risk. In cases where conditionalities conflict with the Global Fund Strategy, we request that the Secretariat propose novel pathways for securing donor pledges and protecting evidence-informed programs. We request innovative thinking around potential Strategic Initiatives to raise funding for critical gaps, such as human rights, gender, and LGBTI programming.

Launch an ambitious strategy on debt. In the event of a permanent US government withdrawal, other public donors will struggle to fill the gap. We note that high levels of debt, particularly in African countries, are constricting the fiscal space and acting as a direct barrier to domestic resource mobilization. **We urge the Global Fund to adopt a leadership role in this space by scaling up its Debt to Health (D2H)** agreements and debt swaps with the condition that the resources will be earmarked towards health, especially the programs impacted by the withdrawals. We suggest this strategy can include using the Replenishment campaigns to negotiate with bilateral and private holders of debt, including the World Bank, the African Development Bank, other regional and national banks in African countries, the Chinese



government, and other key lenders to restructure debt, pause interest on debt in the short term, and support African leaders negotiations and call for debt cancellations.

Looking ahead to GC8

The CHANGE coalition appreciates the Secretariat's efforts to evolve the Global Fund model toward greater sustainability, efficiency, country ownership, smoother transition, and improved impact. However, the health financing situation has significantly evolved since the November Board decisions, and **business as usual is no longer feasible**. We further note the likelihood of making decisions well before Replenishment and GC8, given worrying signals about pledge conversion, and that at least **USD 1 billion in resources** pledged by the United States government that have not yet been contributed.

For the 53rd Board Meeting, **we request the Secretariat to share scenario planning**, risk mitigation, and management strategies for responding to low pledge conversion rates from the 7th Replenishment and a low 8th Replenishment. These strategies and plans must inform the ongoing GC8 planning and must be informed by these principles:

1. **Include transparent, quantitative, and evidence-informed criteria for scaling down resources.** One strength of the Global Fund model has been its commitment to a transparent methodology for allocating resources to countries. Additional criteria and decisions to reduce Global Fund support to countries, regions, or priority areas must be clearly articulated.
2. **Proactive and urgent communication.** Governments, PRs, and partners will require clear and up-to-date information and projections to prevent abrupt defunding of health services and health systems before governments and other partners can scale up.
3. **Protect key and vulnerable populations (KVP) and communities.** KVP programmes are underfunded, under attack, and are fundamental to the response to the three diseases. In particular, US funding withdrawal and stipulations have put these populations under increasing risk, and countries may encounter political challenges when using domestic resources to sustain KVP programmes. We request the Secretariat to promote direct-to-community funding pathways as efficient, high-impact grant modalities—especially in criminalised contexts—and develop multi-country modalities to preserve KVP programmes during transitions.

We additionally note the high **risk of the US government applying conditionalities** to both the remaining R7 contribution and the R8 pledge. We therefore urge that the Secretariat proactively develop a Board-approved strategy for responding to donor requests. This strategy must:

1. Ensure that any conditionalities do not undermine the Global Fund's **ability to deliver on its Strategy**, which recognizes that protecting human rights and gender equality is



required to end HIV, tuberculosis, and malaria, and that the leadership of communities is essential to achieving its objectives.

2. Consider the **risks to country sovereignty** of donor conditionalities, in cases where government-to-government legal agreements would be required. At the core of the Global Fund's partnership model is a commitment to a county-led approach and respect for country laws. Accepting conditionalities that threaten either is a fundamental threat to Global Fund principles.
3. **Outline minimum standards** for the delivery of Global Fund funded commodities and services, based on the principles of community engagement and equity. We note that successful Global Fund programs will require community- and KVP-led services delivery as well as a commitment to funding community wrap out and support services. This should be clearly articulated as a non-negotiable for GC8.



Déclaration de CHANGE

CHANGE (Community Health and HIV Advocates Navigating Global Emergencies) est une coalition de plus de 1 500 personnes issues de la société civile et d'organisations communautaires du monde entier. La coalition a été créée en janvier 2025 pour répondre à l'urgence du financement de la santé déclenchée par le retrait du gouvernement étatsunien de l'aide étrangère. Cette déclaration a été élaborée en partenariat avec des défenseurs, des organisations et des réseaux de la société civile du monde entier qui s'intéressent au VIH, à la tuberculose et au paludisme.

Répondre à la crise de financement

La coalition CHANGE reconnaît les **risques financiers extraordinairement élevés auxquels le Fonds mondial** est confronté dans ce cycle et dans la perspective du cycle de subvention 8. Le retrait rapide et chaotique de l'aide bilatérale des États-Unis et les réductions proposées aux organisations partenaires, y compris l'OMS, l'ONUSIDA et Gavi, ont créé une crise mondiale de la santé. Ce retrait chaotique a permis à d'autres pays donateurs de proposer leurs propres réductions de l'aide au développement, ce qui a aggravé la crise financière. Une analyse récente indique qu'un retrait complet du soutien américain aux programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et d'autres maladies entraînerait 25 millions de décès au cours des 15 prochaines années².

La décision de « ralentir » immédiatement la mise en œuvre des subventions du cycle de subvention 7 (CS7), ainsi que les décisions supplémentaires qui seront prises lors de la réunion du Conseil d'administration concernant la manière de désaffecter les fonds du CS7, comportent des **risques extrêmement élevés pour la vie des personnes** que le Fonds mondial sert. La coalition CHANGE est alarmée par le fait que la communication du Secrétariat a manqué de spécificité, n'a pas sauvegardé des piliers entiers de la stratégie du Fonds mondial, a refusé de mandater la supervision des pays et a été mise en œuvre sans l'engagement du Conseil d'administration et du partenariat.

Nous demandons au Secrétariat de **publier d'urgence des orientations claires à l'intention des pays, y compris des partenaires communautaires et de la société civile**, concernant les ralentissements de la mise en œuvre, les calendriers, la procédure de reprogrammation des subventions du Fonds mondial (y compris les processus visant à garantir l'engagement des communautés dans la prise de décision) pour répondre aux lacunes immédiates laissées par le retrait du financement du gouvernement américain, ainsi que des garde-fous clairs pour sauvegarder les programmes qui sauvent des vies.

² Stover J, Sonneveldt E, Tam Y, Clark R, Phillips AN, et al. [The Effects of Reductions in United States Foreign Assistance on Global Health](#). Lancet (pre-print). 8 Apr 2025.



Le Fonds mondial doit :

1. **Faire savoir que les interventions communautaires sauvent des vies et que le ralentissement de la mise en œuvre du CS7 n'est pas une autorisation de décimer les interventions menées par les communautés.**
2. **Requérir l'approbation de l'ensemble de l'ICN et la contribution de la communauté.** Compte tenu des bouleversements importants qui se produisent dans les pays, du risque élevé de dépriorisation des programmes essentiels et des rapports émergents faisant état d'une aggravation de la stigmatisation, de la discrimination et des obstacles aux soins pour les populations clés et vulnérables, tous les « ralentissements », coupes et reprogrammations doivent s'accompagner d'une documentation sur la manière dont **l'ensemble de l'ICN a été impliqué dans la décision d'interrompre la mise en œuvre ou de reprogrammer les activités et a donné son accord par écrit**. Les efforts de redéfinition des priorités sans l'apport des communautés risquent d'être inefficaces et non stratégiques, car les communautés apportent des données et des renseignements qui font défaut aux systèmes traditionnels. Ces mêmes principes doivent s'appliquer au financement du C19RM et aux investissements catalytiques.
3. **Définir une méthodologie de redéfinition des priorités pour CS7 qui respecte les principes du Fonds mondial.** La réduction rapide des subventions ne doit pas compromettre la capacité de la méthode d'allocation à répondre aux besoins, à l'équité et aux capacités des pays. Il est inacceptable d'accorder un financement préférentiel à des pays en raison de leur rythme d'absorption ou de leur calendrier de mise en œuvre.
4. **Partager immédiatement les orientations relatives à cette pause de mise en œuvre** avec toutes les ICN, ainsi qu'avec la société civile, les populations clés et les réseaux communautaires. Cette communication doit inclure des efforts explicites pour s'assurer que les représentants des ICN et leurs délégations sont pleinement informés, comprennent et participent à la prise de décision sur le processus de ralentissement, de redéfinition des priorités et de reprogrammation. La participation des centres d'apprentissage régionaux et des réseaux mondiaux de populations clés sera essentielle pour s'assurer que les membres des ICN et leurs groupes d'intérêt sont atteints et pleinement soutenus.
5. **Découpler les défis financiers immédiats de la planification du CS8.** La nécessité d'éviter une crise financière due à des promesses non converties devrait être abordée avec une stratégie différente de celle de la planification d'une reconstitution des huit faibles. Nous demandons instamment au Conseil d'administration de suspendre la mise en œuvre au minimum nécessaire pour éviter les problèmes de trésorerie. En parallèle, le Secrétariat doit proposer une méthodologie de réduction, de transition et de priorisation à plus long terme qui aborde de manière holistique les lacunes laissées par



le gouvernement américain, reprogramme vers les besoins urgents et inclut des voies transparentes et réalistes pour la transition et la réduction. Cette question devrait être abordée lors des prochaines réunions des comités.

6. **Veiller à ce que le « ralentissement » et la redéfinition** des priorités s'accompagnent d'une supervision claire du Conseil dans le cas où l'examen complet du CTEP n'est pas possible (par exemple, établir un processus « Expedited-CTEP » pour rationaliser et accélérer l'examen), afin de garantir l'alignement avec les principes opérationnels fondamentaux du Fonds mondial, les structures de gouvernance et le contexte du pays. Dans le processus de « ralentissement » ou de redéfinition des priorités des activités élaborées par les pays, examinées par le CTEP et approuvées par le Secrétariat, les principes de **gouvernance, de supervision et d'orientation des programmes du Fonds mondial ne peuvent être abandonnés au profit de l'opportunisme financier.**
7. **S'accompagner d'une diffusion régulière, granulaire et publique des données.** Les changements rapides apportés aux budgets des subventions créent un risque alarmant pour la transparence. Le Secrétariat doit s'engager à publier des rapports complets sur les interventions, à quel coût, qui ont été affectées au niveau des pays et des portefeuilles de maladies à la suite des efforts de redéfinition des priorités. En outre, bien que la mise en œuvre du CS7 ait commencé il y a plus de 16 mois, aucune donnée d'absorption n'a été publiée pour l'ensemble du cycle. Alors que les pays commencent à interrompre leurs programmes et à orienter les budgets de subvention vers les lacunes émergentes, ces données doivent être publiées afin de permettre une redéfinition des priorités qui minimise la perturbation des programmes existants.
8. **S'accompagner d'une analyse au niveau du portefeuille par le Secrétariat** afin de tirer parti du budget d'allocation non dépensé par le biais de l'optimisation du portefeuille et d'autres voies, de soutenir la redistribution des stocks de médicaments nationaux pour résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, d'augmenter les achats groupés et de négocier des économies supplémentaires. Cela doit inclure la planification de scénarios. Nous demandons instamment au Secrétariat de publier des **directives obligatoires à l'intention des équipes nationales afin de mettre en place des garde-fous** concernant le financement des programmes axés sur les communautés.

Mise à jour sur la mobilisation des ressources

Nous demandons instamment aux donateurs d'honorer les engagements pris lors de la 7e reconstitution des ressources.

Notant le risque très élevé d'un scénario de faible reconstitution des ressources, nous demandons instamment au Fonds mondial d'adopter une approche ambitieuse de la mobilisation des ressources. Celle-ci devrait inclure l'élaboration de propositions de nouveaux



mécanismes de financement pour les donateurs, y compris le secteur privé, mais aussi les donateurs du secteur public. Nous demandons instamment au Secrétariat d'envisager les approches suivantes :

Un appel à des voies créatives pour les engagements des donateurs qui garantissent des ressources pour le Fonds mondial tout en protégeant sa stratégie de base. En tant qu'institution multilatérale soutenant des programmes menés par les pays et fondés sur des données probantes, l'imposition de conditionnalités par les donateurs sur les ressources du Fonds mondial crée un risque important. Dans les cas où les conditionnalités sont en conflit avec la stratégie du Fonds mondial, nous demandons au Secrétariat de proposer de nouvelles voies pour garantir les promesses des donateurs et protéger les programmes fondés sur des données probantes. Nous demandons une réflexion innovante sur les initiatives stratégiques potentielles afin de collecter des fonds pour combler des lacunes critiques, telles que les droits de l'homme, l'égalité des sexes et les programmes LGBTI.

Lancer une stratégie ambitieuse en matière de dette. En cas de retrait définitif du gouvernement américain, les autres donateurs publics auront du mal à combler le fossé. Nous constatons que les niveaux élevés d'endettement, en particulier dans les pays africains, restreignent l'espace budgétaire et constituent un obstacle direct à la mobilisation des ressources nationales. **Nous demandons instamment au Fonds mondial de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine en renforçant ses accords de conversion de la dette en faveur de la santé (D2H)** et ses échanges de dettes, à condition que les ressources soient affectées à la santé, en particulier aux programmes touchés par les retraits. Nous suggérons d'utiliser les campagnes de reconstitution des ressources pour négocier avec les détenteurs bilatéraux et privés de la dette, y compris la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, d'autres banques régionales et nationales dans les pays africains, le gouvernement chinois et d'autres prêteurs importants, afin de restructurer la dette, de suspendre les intérêts sur la dette à court terme et de soutenir les négociations des dirigeants africains et d'appeler à l'annulation de la dette.

En route vers le CS8

La coalition CHANGE apprécie les efforts du Secrétariat pour faire évoluer le modèle du Fonds mondial vers plus de durabilité, d'efficacité, d'appropriation par les pays, de transition en douceur et d'amélioration de l'impact. Cependant, la situation du financement de la santé a considérablement évolué depuis les décisions prises par le Conseil en novembre, et **il n'est plus possible de maintenir le statu quo**. Nous notons en outre qu'il est probable que des décisions soient prises bien avant la reconstitution des ressources et le CS8, compte tenu des signaux inquiétants concernant la conversion des promesses et du fait qu'au moins **1 milliard d'USD de ressources** promises par le gouvernement des États-Unis n'ont pas encore été versés.



Pour la 53ème réunion du Conseil d'administration, **nous demandons au Secrétariat de partager des stratégies de planification de scénarios**, d'atténuation des risques et de gestion pour répondre aux faibles taux de conversion des promesses de la 7ème reconstitution des ressources et à une faible 8ème reconstitution des ressources. Ces stratégies et plans doivent informer la planification en cours de la CS8 et doivent être informés par ces principes :

1. **Inclure des critères transparents, quantitatifs et fondés sur des données probantes pour la réduction des ressources.** L'un des points forts du modèle du Fonds mondial est son engagement en faveur d'une méthodologie transparente pour l'allocation des ressources aux pays. Les décisions visant à réduire le soutien du Fonds mondial à des pays, des régions ou des domaines prioritaires doivent être clairement formulées.
2. **Une communication proactive et urgente.** Les gouvernements, les PR et les partenaires auront besoin d'informations et de projections claires et actualisées pour éviter que les services et les systèmes de santé ne soient brusquement dégraisés avant que les gouvernements et les autres partenaires ne puissent passer à l'échelle supérieure.
3. **Protéger les populations clés et vulnérables (PCV) et les communautés.** Les programmes PCV sont sous-financés et attaqués, alors qu'ils sont essentiels à la lutte contre les trois maladies. En particulier, le retrait du financement étatsunien et les stipulations qui en découlent ont mis ces populations de plus en plus en danger, et les pays peuvent se heurter à des difficultés politiques lorsqu'ils utilisent des ressources nationales pour soutenir les programmes PCV. Nous demandons au Secrétariat de promouvoir les voies de financement directes aux communautés en tant que modalités de subvention efficaces et à fort impact - en particulier dans les contextes criminalisés - et de développer des modalités multi-pays pour préserver les programmes de PCV pendant les transitions.

Nous notons en outre le **risque élevé que le gouvernement étatsunien applique des conditionnalités** à la fois à la contribution restante de la R7 et à la promesse de la R8. Nous demandons donc instamment au Secrétariat d'élaborer de manière proactive une stratégie approuvée par le Conseil d'administration pour répondre aux demandes des donateurs. Cette stratégie doit :

1. Veiller à ce que les conditionnalités ne compromettent pas la **capacité du Fonds mondial à mettre en œuvre sa stratégie**, qui reconnaît que la protection des droits de l'homme et l'égalité des genres sont nécessaires pour mettre fin au VIH, à la tuberculose et au paludisme, et que le leadership des communautés est essentiel à la réalisation de ses objectifs.



2. Tenir compte des **risques que les conditionnalités des donateurs font peser sur la souveraineté des pays**, dans les cas où des accords juridiques de gouvernement à gouvernement seraient nécessaires. Le modèle de partenariat du Fonds mondial repose sur un engagement en faveur d'une approche dirigée par les pays et sur le respect des lois nationales. Accepter des conditionnalités qui menacent l'un ou l'autre constitue une menace fondamentale pour les principes du Fonds mondial.
3. **Définir des normes minimales** pour la fourniture des produits et services financés par le Fonds mondial, sur la base des principes d'engagement communautaire et d'équité. Nous notons que les programmes réussis du Fonds mondial nécessiteront une prestation de services dirigée par la communauté et le PCV, ainsi qu'un engagement à financer les services de soutien et d'accompagnement de la communauté. Ceci devrait être clairement articulé comme un élément non négociable pour le CS8.



Déclaration de **CHANGE**

CHANGE (Community Health and HIV Advocates Navigating Global Emergencies) est une coalition de plus de 1 500 personnes issues de la société civile et d'organisations communautaires du monde entier. La coalition a été créée en janvier 2025 pour répondre à l'urgence du financement de la santé déclenchée par le retrait du gouvernement étatsunien de l'aide étrangère.

